Estratégia MED

TRAUMA DE FACE



Renatha Paiva

CRM: 109.768

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

TRAUMA DE FACE



Renatha Paiva

CRM: 109.768

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRAUMA DE FACE

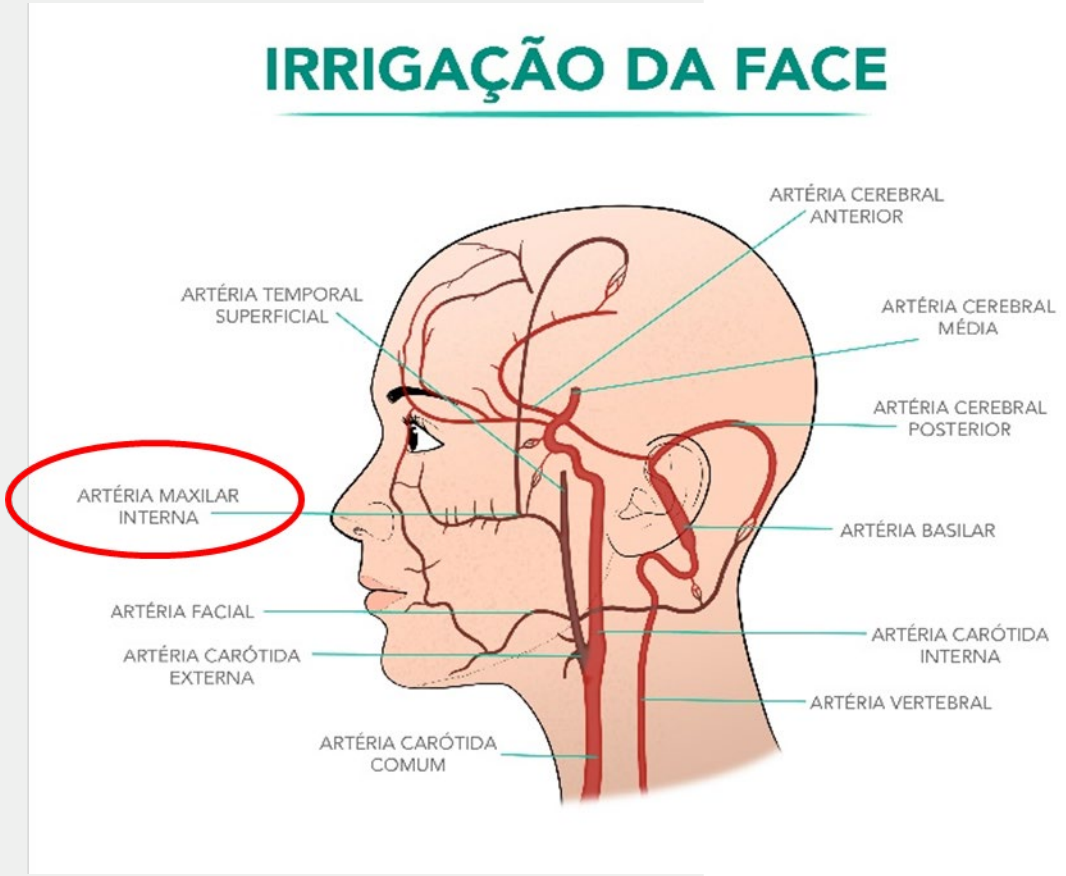
AVALIAÇÃO INICIAL – ATLS	
"A" (AIRWAY)	Proteção das vias aéreas + imobilização da coluna cervical
"B"(BREATHING)	Respiração e ventilação
"C" (CIRCULATION)	CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA
"D" (DISABILITY)	Estado neurológico
"E" (EXPOSURE AND ENVIROMENTAL CONTROL)	Exposição e controle ambiental (evitando hipotermia)



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRAUMA DE FACE

- Comprometimento da via aérea
- A hemorragia também pode ser significativa.
  - ✓Compressão/ligadura vascular
  - ✓Embolização



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

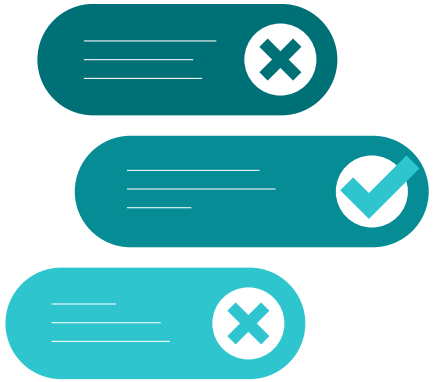
De acordo com o ATLS, no paciente com história de trauma facial, deve-se dar prioridade à:

A) Ausculta pulmonar.

B) Reposição volêmica.

C) Tomografia computadorizada.

D) Permeabilidade das vias aéreas.



Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FRATURA DE FACE

- Rx - **TOMOGRAFIA**
- Priorizar lesões mais graves.
- Clínica (sinais de certeza): mobilidade, crepitação, deformidade, imagem radiográfica e assimetria.
- Tratamento:

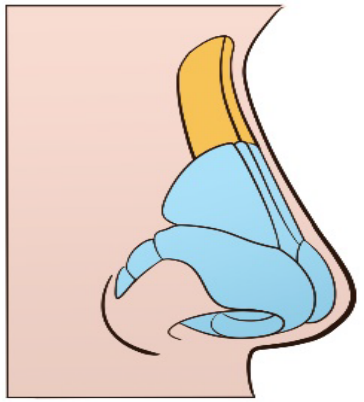
✓A maioria não tem indicação de cirurgia imediata

✓Risco de deformidade estética

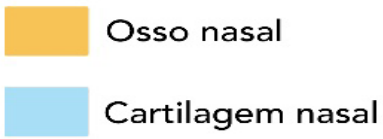
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FRATURA NASAL

- Fratura facial mais comum no trauma facial
- Clínica: equimose palpebral, edema local, desvio ou afundamento do dorso nasal, crepitação à palpação e epistaxe.
- Diplopia, telecanto (secundários a fratura naso-orbitoetmóide), anosmia.
- Tratamento: redução da fratura geralmente em 3-7 dias (redução do edema).
- Tratamento cirúrgico de urgência:
  - ✓Fraturas nasais abertas;
  - ✓Associação com fratura na parte anterior da base de crânio;
  - ✓Complicações: lesão de vias lacrimais, hematoma de septo (abscessos septais podem levar a necrose e erosão do septo por pressão prolongada), fístula liquórica, sangramento abundante, alteração visual).



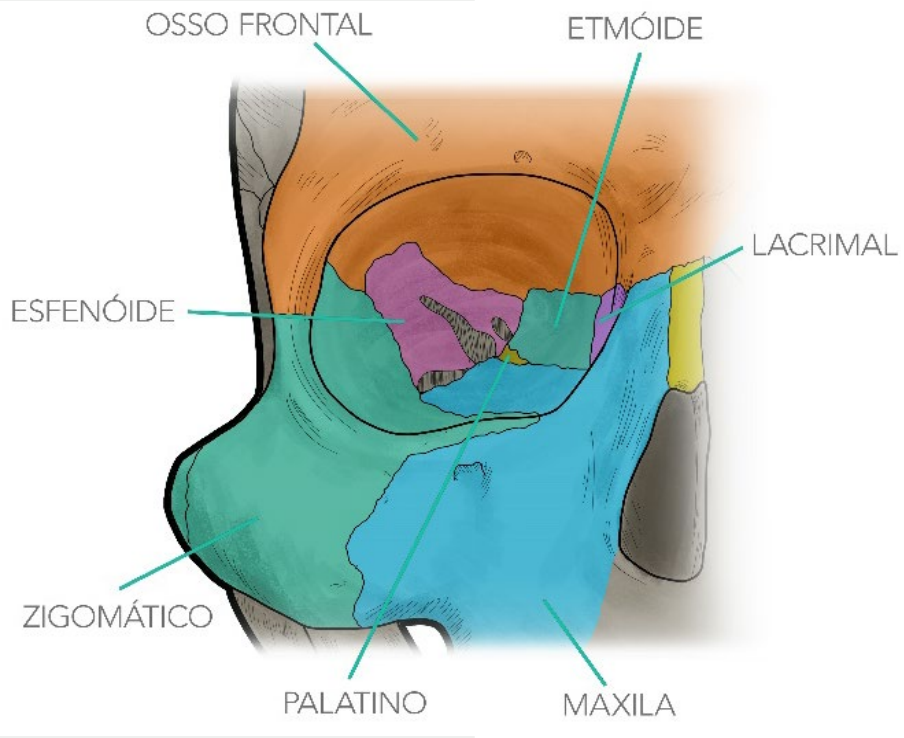




Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FRATURA DE ZIGOMÁTICO

- hemorragia subconjuntival e equimose periorbital;
- degraus palpáveis no sulco súperolateral da órbita, inferior da órbita e vestibular superior;
- enfisema dentro da órbita ou tecidos moles sobrejacentes da bochecha;
- trismo;
- **diplopia, enoftalmia e distúrbios de mobilidade do globo ocular = comprometimento do nervo infraorbitário/musc. extrínseca da órbita**

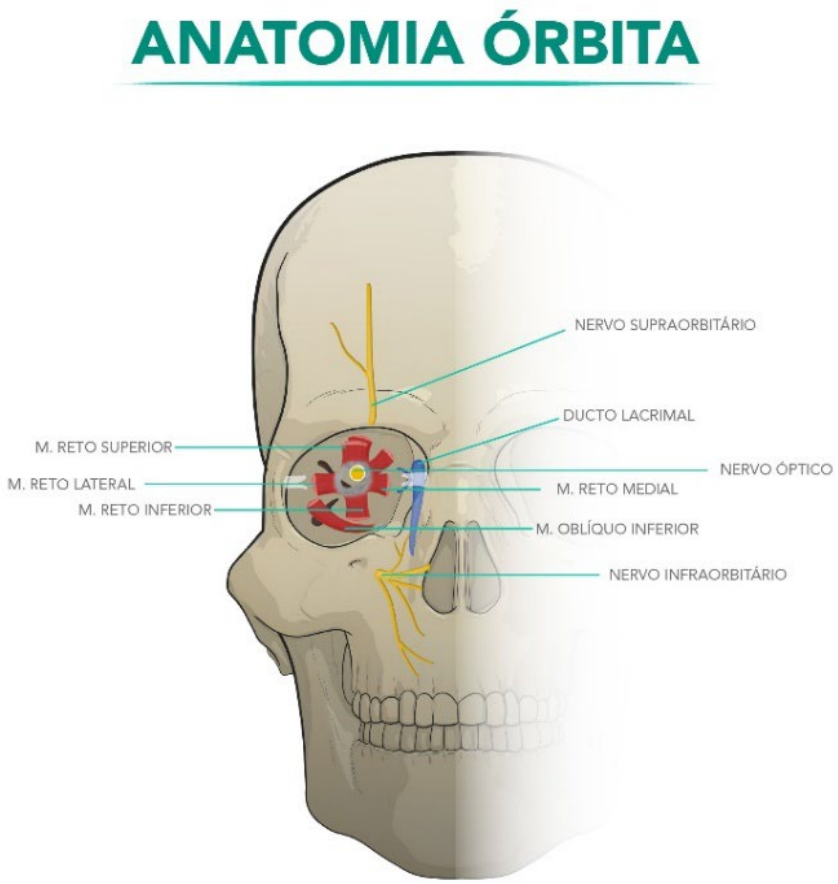


Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FRATURA DA ÓRBITA

- Clínica: dor, edema e equimose periorbital;
- Alterações visuais: enoftalmia, aprisionamento muscular extraocular com distopia orbital, parestesia em hemiface (aprisionamento do nervo infraorbitário) ou exoftalmia (hematoma retrobulbar).
- As paredes **medial** e inferior: locais mais comuns de fraturas
- A parede lateral (zigomático, asa maior do esfenoide e osso frontal): mais forte e mais espessa.

A parede lateral da órbita é a mais forte, e a medial é a mais frágil.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

OUTRAS FRATURAS

MANDÍBULA

- Único osso móvel da face
- Segunda fratura mais comum
- Tratamento: redução e fixação o mais precoce possível

FRONTAL

- Menos acometido (maior resistência)
- TCE associado = lesões mais graves
- Tratamento cirúrgico: incisão cirúrgica bicoronal (expõe as regiões frontal, nasal, orbital e zigomática)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

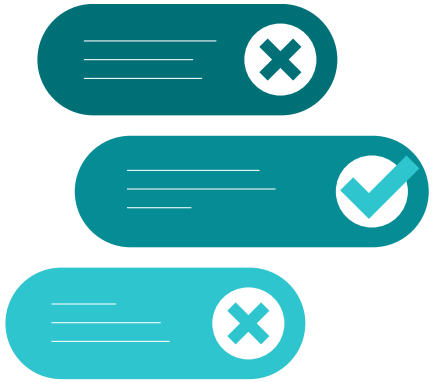
No exame físico do serviço de emergência, o trauma facial é uma possibilidade frequente. Do ponto de vista da traumatologia facial,

A) a classificação das fraturas da mandíbula é o Le Fort 1, 2 e 3.

B) as alterações da sensibilidade do nervo infraorbitário podem ocorrer nas fraturas de mandíbula.

C) a oclusão dentária alterada indica sinais de fratura nasal.

D) a fratura nasal é a mais frequente.



Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

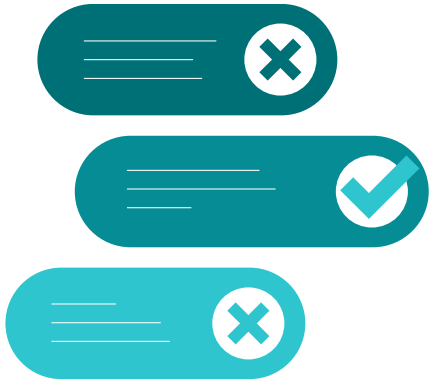
Assinale a afirmação INCORRETA.

A) Equimose das pálpebras, desvio ou afundamento do dorso nasal, crepitação à palpação e epistaxe são os sintomas mais frequentes de fratura nasal.

B) As fraturas do osso zigomático podem passar despercebidas em um trauma de face, podendo causar deformidades estéticas e problemas funcionais graves se não tratadas.

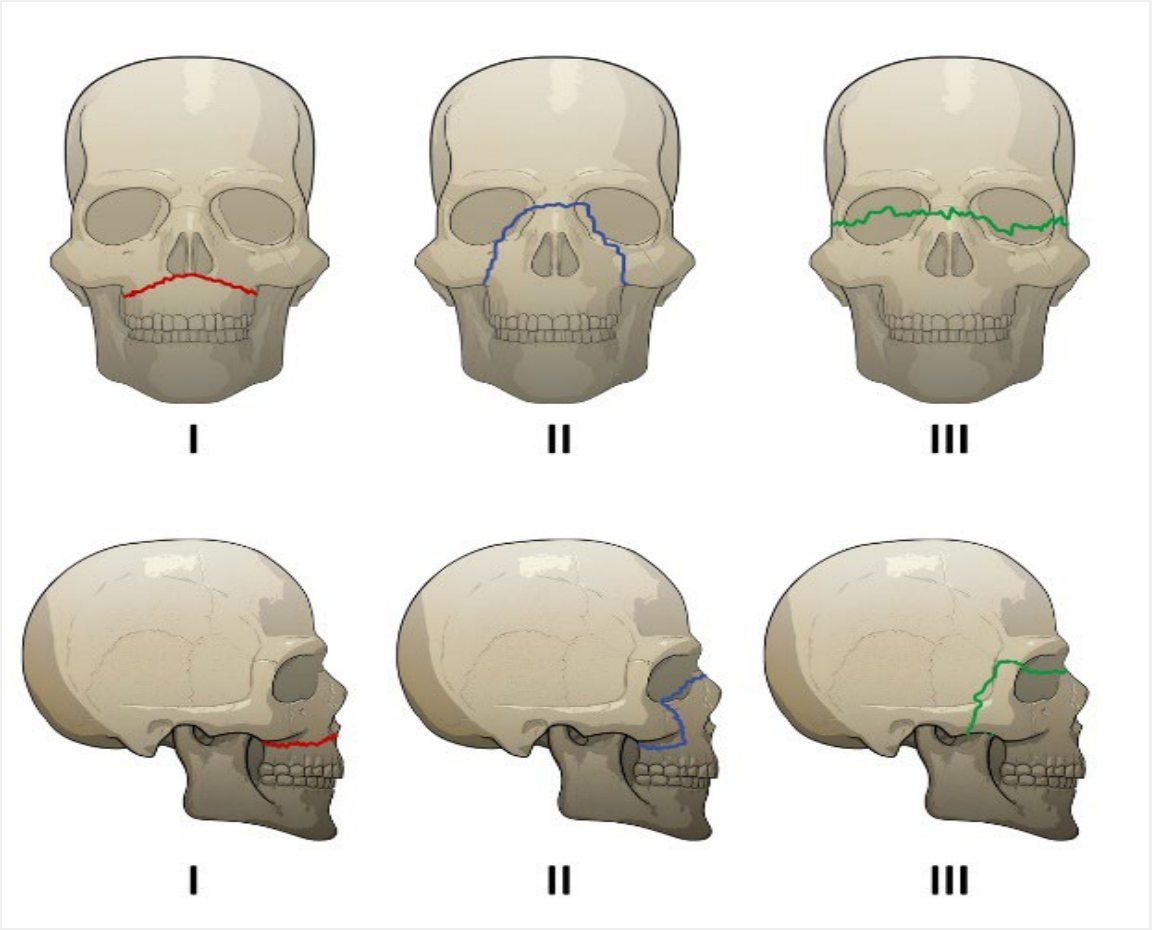
C) Diplopia e dificuldade de movimentação do globo ocular para cima podem ocorrer nas fraturas do osso zigomático.

D) O nariz é raramente acometido nas fraturas de face e, quando ocorre, deve ser tratado imediatamente, antes de 24h, para evitar deformidades.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CLASSIFICAÇÃO DE LE FORT

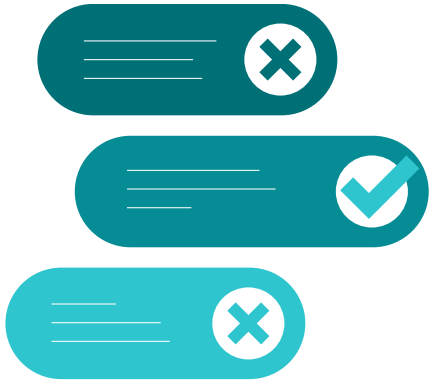


Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LE FORT – FRATURA DA FACE MÉDIA

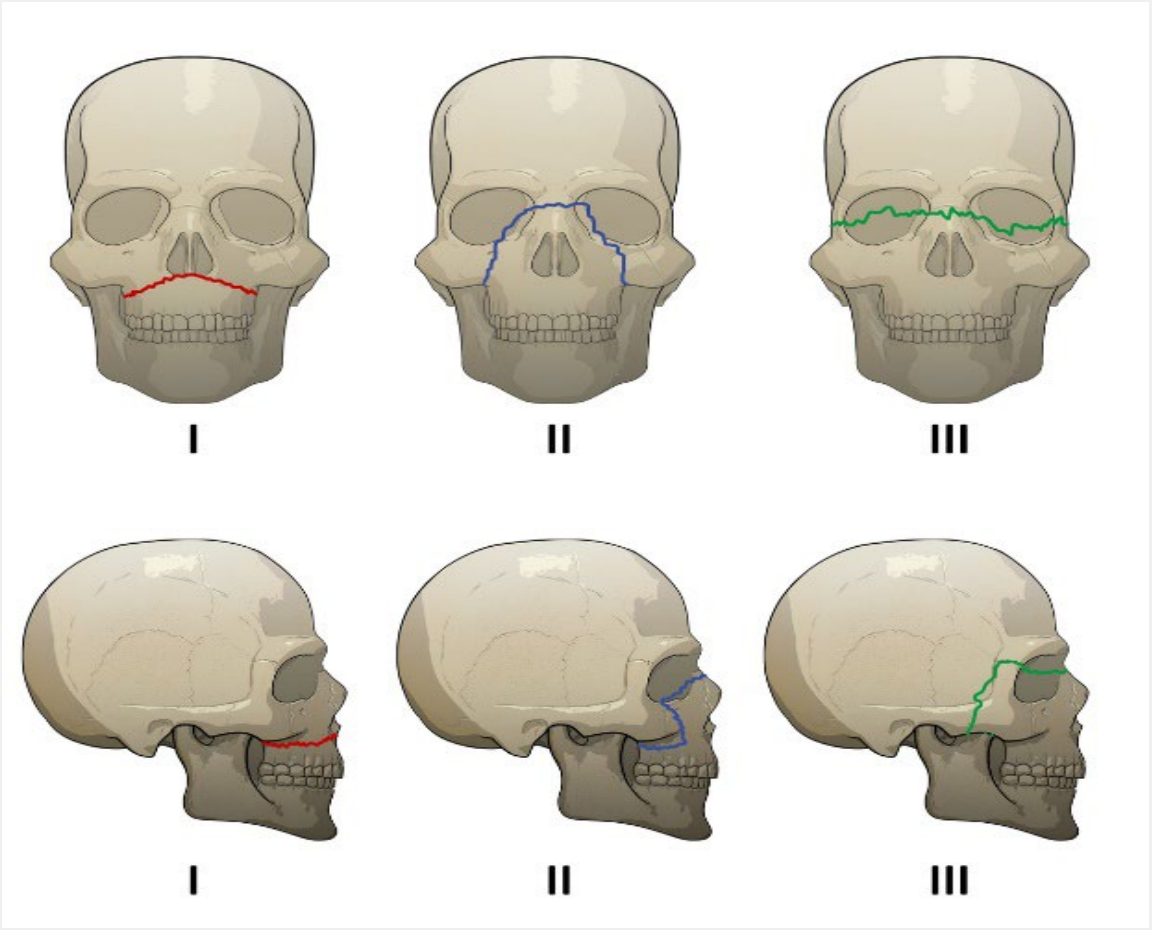
Le Fort I: envolvem uma fratura transversal através da maxila acima das raízes dos dentes. Também conhecidas como fraturas de Guérin ou disjunção dentoalveolar ou fratura transversa. Separa os processos alveolares, dentes e palato do resto do crânio. A lesão pode ser unilateral ou bilateral. O segmento mobilizado é o infranasal, e geralmente há edema, epistaxe e equimose no sulco gengivobucal superior.

LeFort II: são fraturas tipicamente bilaterais e envolvem fraturas que se estendem superiormente na face média para incluir o osso nasal, maxila, ossos lacrimais, assoalho orbital. As linhas de fratura têm o formato de uma pirâmide, por isso também é conhecida como fratura piramidal . A linha de fratura é supranasal e separa os ossos nasal e maxilar do osso frontal e da órbita.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

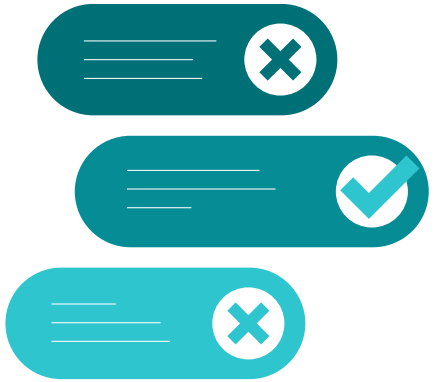
CLASSIFICAÇÃO DE LE FORT



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

LE FORT

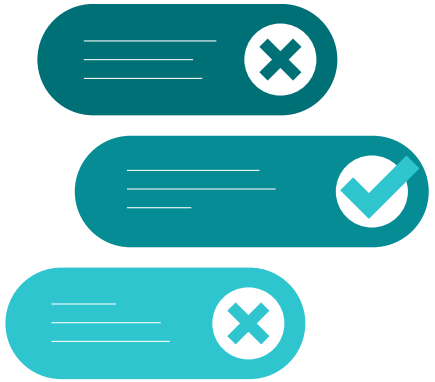
LeFort III: Ocorre uma disjunção craniofacial. Envolvem fraturas que resultam em descontinuidade entre o crânio e a face. As fraturas começam na sutura frontonasal e se estendem posteriormente ao longo da parede medial da órbita e no assoalho da órbita, e depois através da parede orbital lateral e do arco zigomático (fratura naso-orbito-etmoidal, zigomático e maxila). Intranasalmente, eles se estendem por todos os ossos inferiores até a base do esfenóide e são frequentemente associados a um vazamento de líquido cefalorraquidiano (LCR).



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

Homem de 45 anos de idade, condutor de veículo, sofreu colisão frontal contra anteparo fixo. Não estava usando cinto de segurança. No local do acidente, estava irresponsivo. A equipe de Atendimento Pré-Hospitalar encontrou o para-brisa quebrado com vários estilhaços dentro do veículo e o volante deformado. Chegou ao hospital trazida pelo suporte básico do SAMU 192, imobilizada em prancha longa, com colar cervical, ventilado com dispositivo de máscara de 02 com válvula e balão. Apresentava trauma facial extenso com muito sangue na boca e no nariz. Saturação 02 = 80%. A equipe de emergência iniciou o atendimento inicial e solicitou exames radiológicos. O laudo do RX de face foi o seguinte: **"linhas de fraturas oblíquas acometendo o osso nasal e estendendo-se pelas paredes mediais e a margem interna da órbita reconhecível pela mobilidade central da face".** A conduta imediata que deverá ser realizada na sala de emergência e o diagnóstico da fratura da face são, respectivamente:



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

A conduta imediata que deverá ser realizada na sala de emergência e o diagnóstico da fratura da face são, respectivamente:

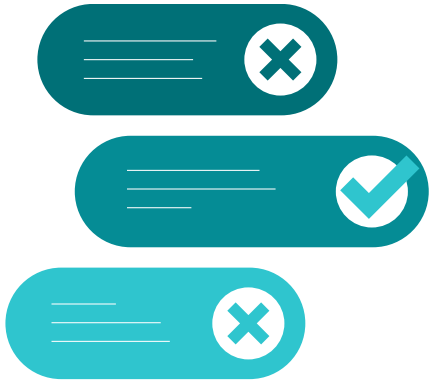
a) Intubação orotraqueal – Le Fort I.

b) Intubação orotraqueal – Le Fort III.

c) Cricotireoidostomia – Le Fort II.

d) Cricotireoidostomia – Le Fort III.

e) Traqueostomia – Le Fort IV.



Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

OBRIGADA



prof.renathapaiva

estrategiamed

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

TRAUMA CERVICAL



Renatha Paiva

CRM: 109.768

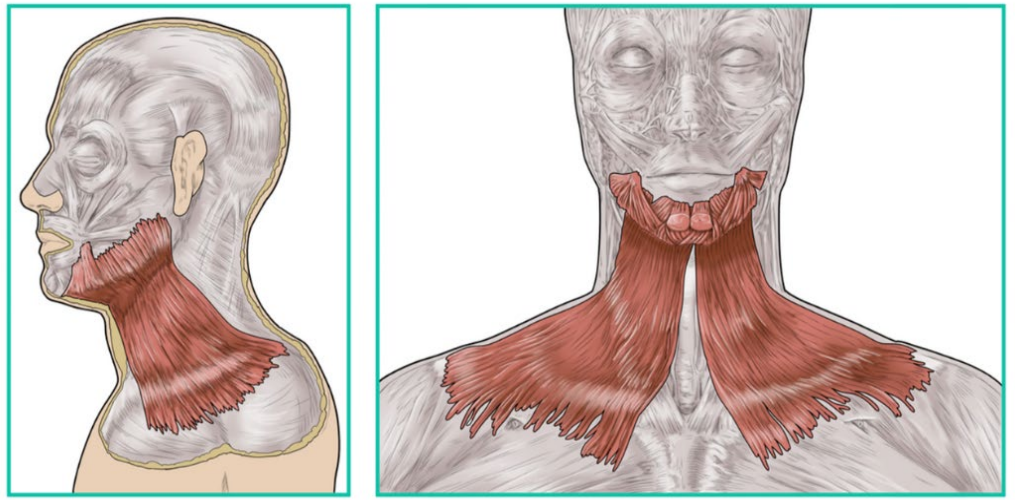
med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRAUMA CERVICAL

- **As lesões penetrantes são o mecanismo de trauma mais comum**
- É considerado ferimento cervical penetrante quando há ultrapassagem do músculo platisma,

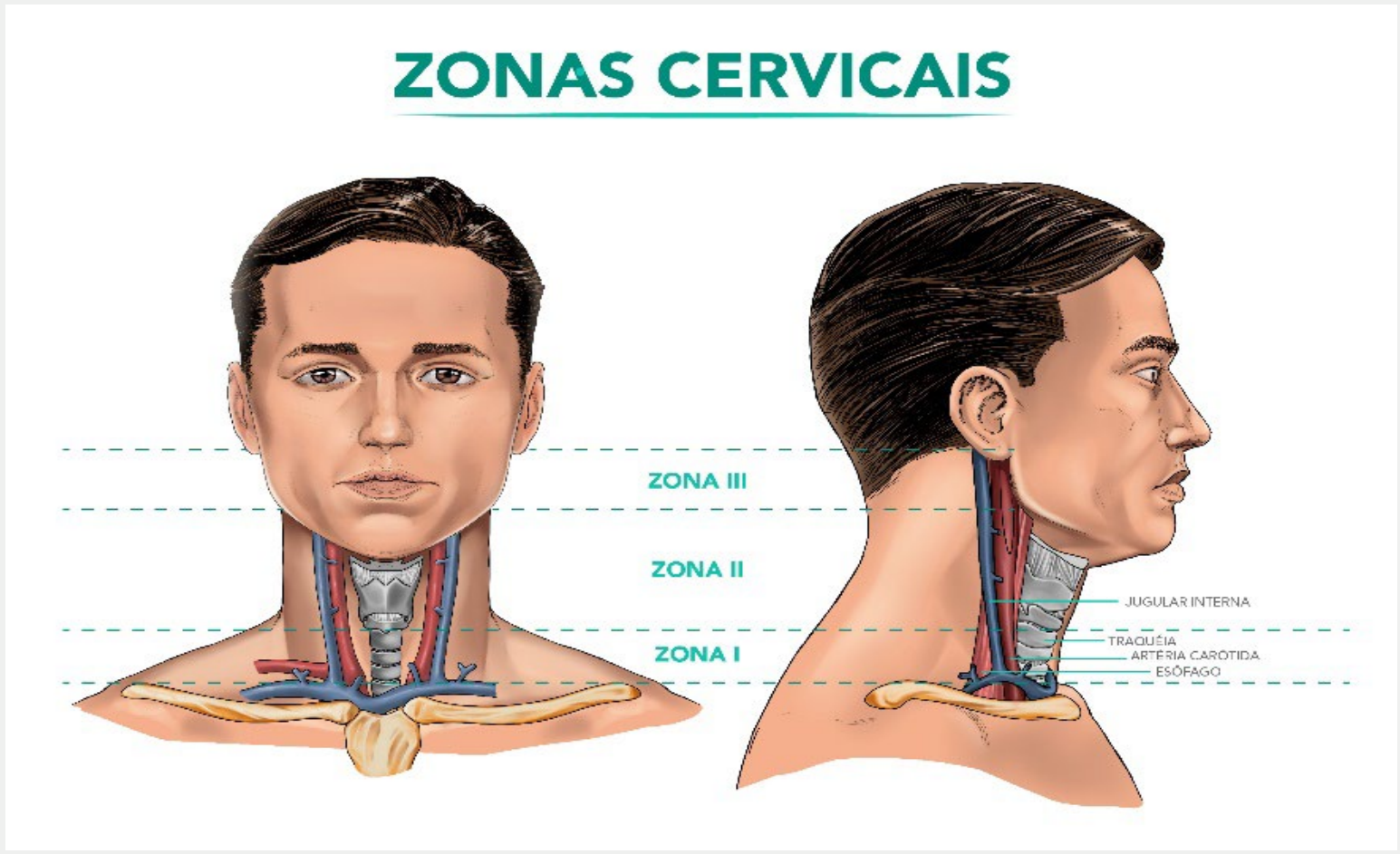
PLATISMA





Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRAUMA CERVICAL



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

QUADRO CLÍNICO

Lesões vasculares: hematoma (em expansão ou pulsátil), choque, sangramento ativo, sopros e frêmitos, pulsos periféricos diminuídos ou ausentes, déficit neurológico (por exemplo, acidente vascular cerebral, hemiplegia).

Lesões laringotraqueais: desconforto respiratório, estridor, enfisema subcutâneo, hemoptise, odinofagia e disfonia/rouquidão.

Lesões faringoesofágicas: disfagia, saliva com sangue, hematêmese e enfisema subcutâneo. Tem alta morbimortalidade pelo risco de mediastinite.



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

AVALIAÇÃO INICIAL – ATLS	
"A" (AIRWAY)	Proteção das vias aéreas + imobilização da coluna cervical
"B"(BREATHING)	Respiração e ventilação
"C" (CIRCULATION)	CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA
"D" (DISABILITY)	Estado neurológico
"E" (EXPOSURE AND ENVIROMENTAL CONTROL)	Exposição e controle ambiental (evitando hipotermia)



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

Sinais sugestivos de necessidade de via aérea definitiva no trauma cervical



- ✓ Hematoma volumoso no pescoço (**deslocamento e obstrução da via aérea**)
- ✓ Distorção da anatomia cervical (desvio de traqueia)
- ✓ Hemoptise franca (sangramento das vias aéreas superiores)
- ✓ Enfisema subcutâneo extenso do pescoço
- ✓ Sopro ou frêmito
- ✓ Estridor
- ✓ Disfagia e odinofagia
- ✓ Rouquidão



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

VIA AÉREA DEFINITIVA - INDICAÇÕES

- Apneia, incapacidade de manter oxigenação
- Risco de aspiração:
  - ✓Paciente inconsciente / GL ≤ 8
  - ✓Sangramento profuso de via aérea
  - ✓Convulsões reentrantes
- Risco iminente de comprometimento da via aérea
  - ✓Trauma maxilofacial extenso
  - ✓Lesão térmica/inalatória
  - ✓**Hematoma cervical expansivo**



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

VIA AÉREA DEFINITIVA





Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

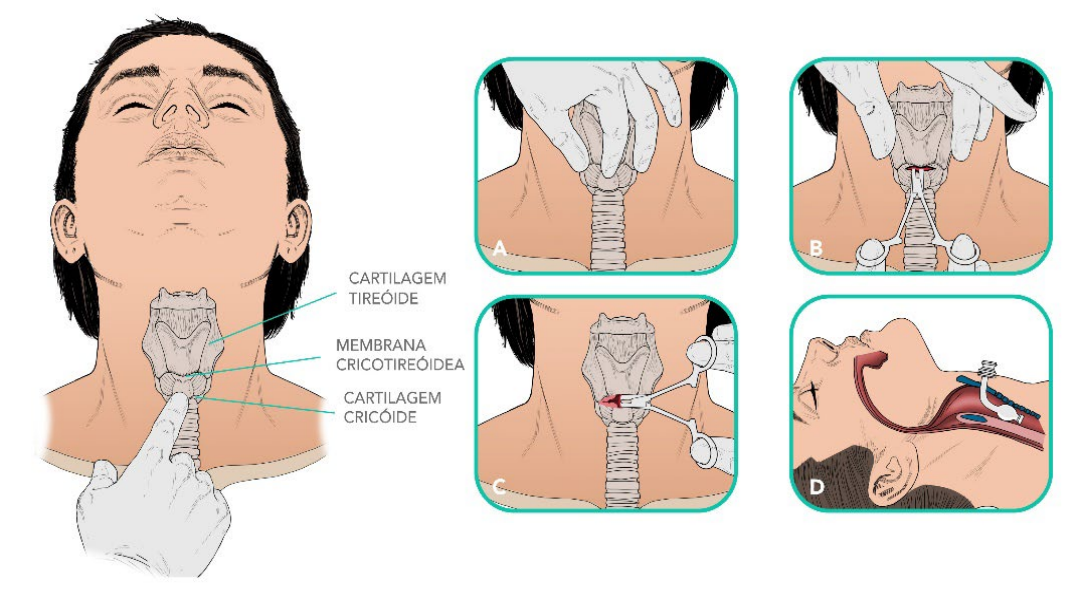
A- VIAS AÉREAS E IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL

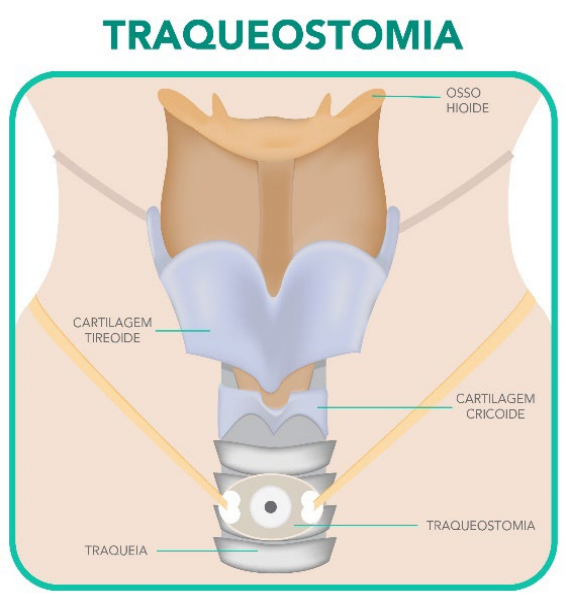
- IOT
- Cricotireoidostomia
  - ✓Falha de intubação orotraqueal;
  - ✓**Distorção anatômica das vias aéreas superiores (por exemplo, desvio de traqueia causado por hematoma cervical volumoso);**
  - ✓Traumatismo facial extenso com sangramento orofaríngeo importante que impossibilita a aspiração adequada e visualização das cordas vocais;
  - ✓Edema de glote.
- Traqueostomia
  - ✓Fratura de laringe: **rouquidão, enfisema subcutâneo e fratura palpável**
  - ✓Crianças < 12 anos



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO



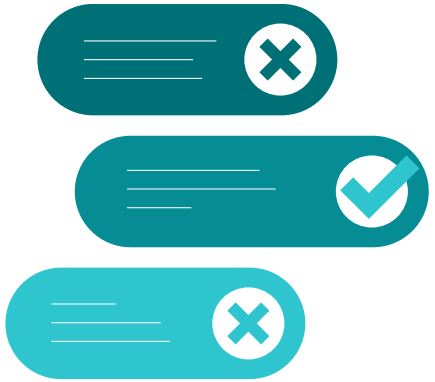




Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

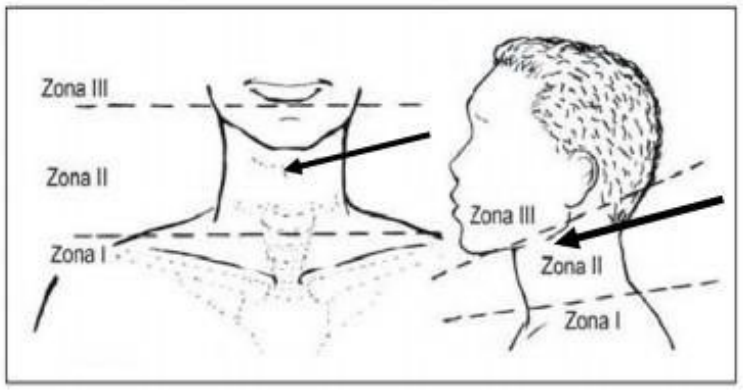
O esquema abaixo representa um paciente vítima de um ferimento cervical penetrante por arma branca. As setas indicam a trajetória do objeto cortante com entrada à esquerda, pelo triângulo posterior do pescoço e sem orifício de saída. O paciente foi admitido consciente, sem déficit motor ou sensitivo, respondendo às perguntas com voz ligeiramente rouca e com dispnéia mínima, normotenso e estável hemodinamicamente. Apresentava discreto hematoma à esquerda com dificuldade para a palpação do pulso carotídeo. Durante a execução da avaliação primária, apresentou **piora da rouquidão, enfisema de subcutâneo e aumento do hematoma cervical,** porém mantendo-se calmo e hemodinamicamente estável. Qual a conduta a ser tomada durante esta avaliação: (Conforme imagem do caderno de questões).



Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova



Mattox KL, Feliciano DV, Moore EE - Trauma, 4ª. ed. p. 438. United States of America - McGraw-Hill, 2000

A) Máscara de O2 15L/min, observação e continuar a avaliação primária

B) Máscara de O2 15L/min e encaminhamento à angiografia

C) Máscara de O2 15L/min e encaminhamento para endoscopia digestiva alta

D) Intubação orotraqueal.

Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

B- RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

C- CONTROLE DE HEMORRAGIA

- Reanimação volêmica
- Compressão direta
- Passagem de cateter balonado: medida temporária
- Tratamento cirúrgico imediato? Exames complementares ?



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

Catarina, 27 anos, vítima de lesão por arma branca em região cervical lateral esquerda. O resgate informa que a paciente perdeu muito sangue no local do acidente. A paciente encontra-se alcoolizada, agitada, com FR: 21 ipm, FC: 110 bpm e PA: 85x53 mmHg. A conduta imediata a ser adotada no caso é:

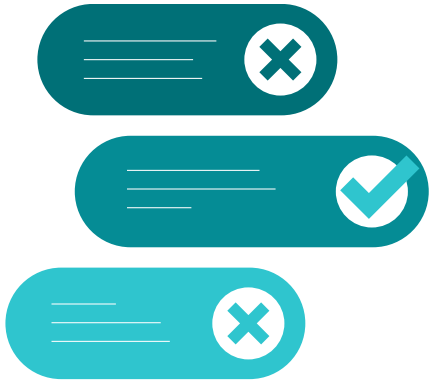
A) Realizar cervicotomia exploradora

B) Realizar intubação orotraqueal

C) Realizar ultrassonografia cervical

D) Realizar cricotireoidostomia cirúrgica

E) Obter acesso venoso e reposição volêmica



Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

INDICAÇÕES DE CERVICOTOMIA EXPLORADORA IMEDIATA

1. Instabilidade hemodinâmica
2. Sangramento ativo
3. Hematoma volumoso e/ou pulsátil e/ou em expansão
4. Lesões “óbvias” de via aerodigestiva:

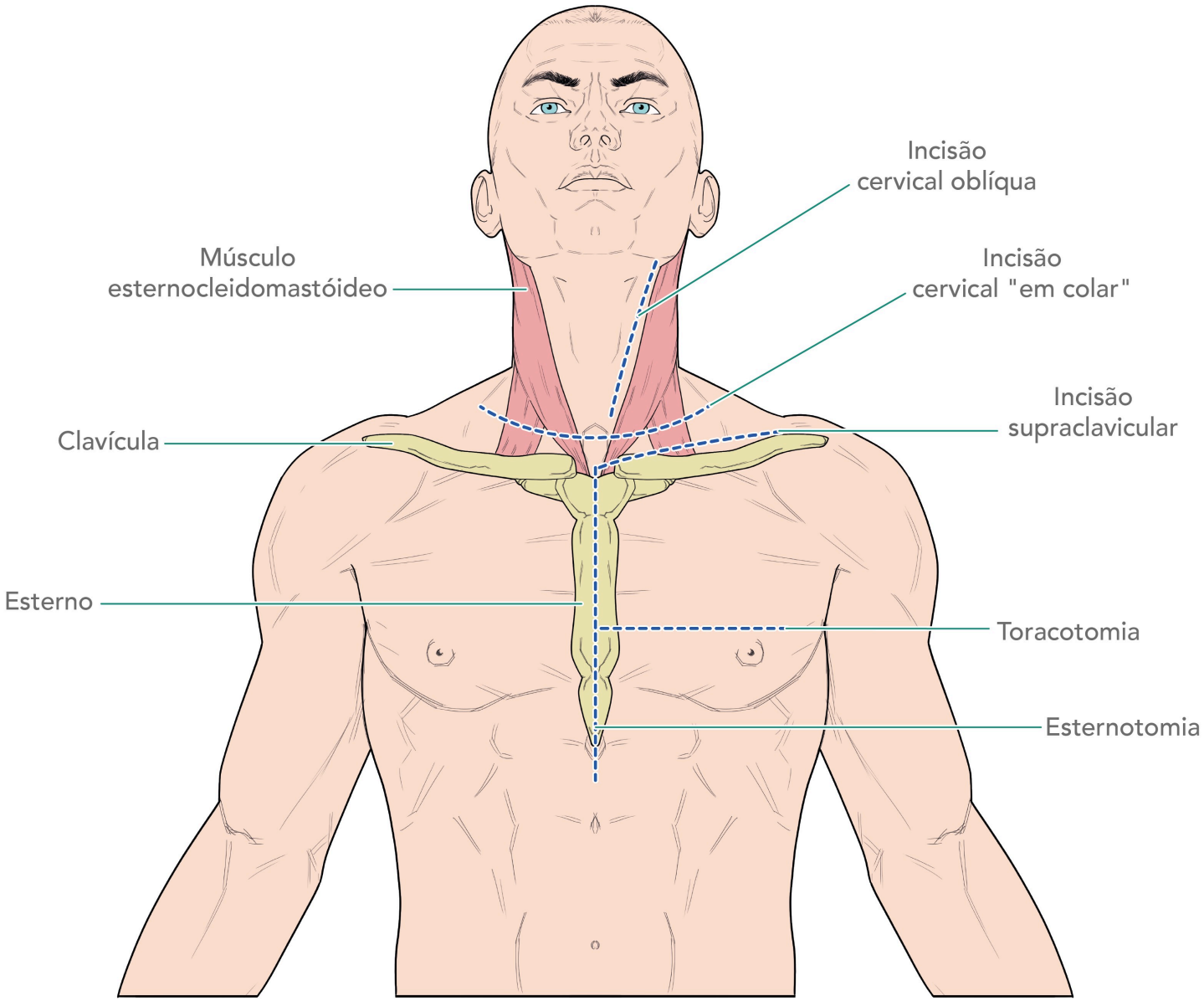
- Ar borbulhando na ferida
- Insuficiência respiratória
- Saída de saliva pelo orifício da lesão
- Enfisema subcutâneo ou mediastinal
- Disfonia/rouquidão/Estridor
- Disfagia





Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ACESSOS CIRÚRGICOS



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

Paciente, 38 anos, deu entrada em Unidade de Emergência vítima de ferimento de arma branca em região cervical. Ao exame: presença de lesão pérfuro-cortante em zona II do pescoço com **sangramento ativo moderado pela ferida operatória; presença de hematoma significativo**. Paciente se encontrava consciente, orientado, estável hemodinamicamente. Qual a conduta a ser adotada?

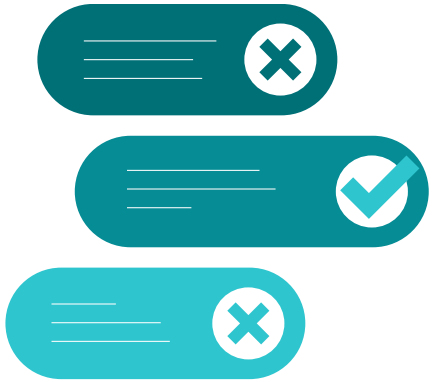
A) Curativo compressivo local e angiografia antes da exploração.

B) Compressão local, intubação traqueal e cirurgia imediata.

C) Curativo compressivo local e tomografia computadorizada cervical antes da exploração.

D) Sutura da pele, curativo compressivo, endoscopia digestiva alta e tomografia computadorizada cervical.

E) Sutura da pele, curativo compressivo e exames complementares se piora do hematoma.



Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

Paciente, vítima de ferimento penetrante por projétil de arma de fogo em porção média cervical anterior à esquerda, entre a cartilagem cricoide e o ângulo da mandíbula, apresenta **enfisema subcutâneo e saída de ar pelo orifício de entrada.** Assinale a alternativa que contém a melhor conduta para esse paciente.

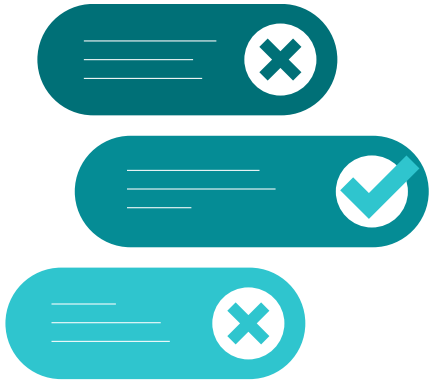
A) Drenagem de tórax fechada à esquerda.

B) Exploração cirúrgica por incisão oblíqua ao longo da borda anterior do músculo esternocleidomastoide esquerdo.

C) Broncoscopia rígida e monitorização em UTI.

D) Endoscopia digestiva alta, passagem de sonda nasoenteral e exame contrastado do esôfago.

E) Tomografia cervical com contraste endovenoso e conduta expectante.



Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

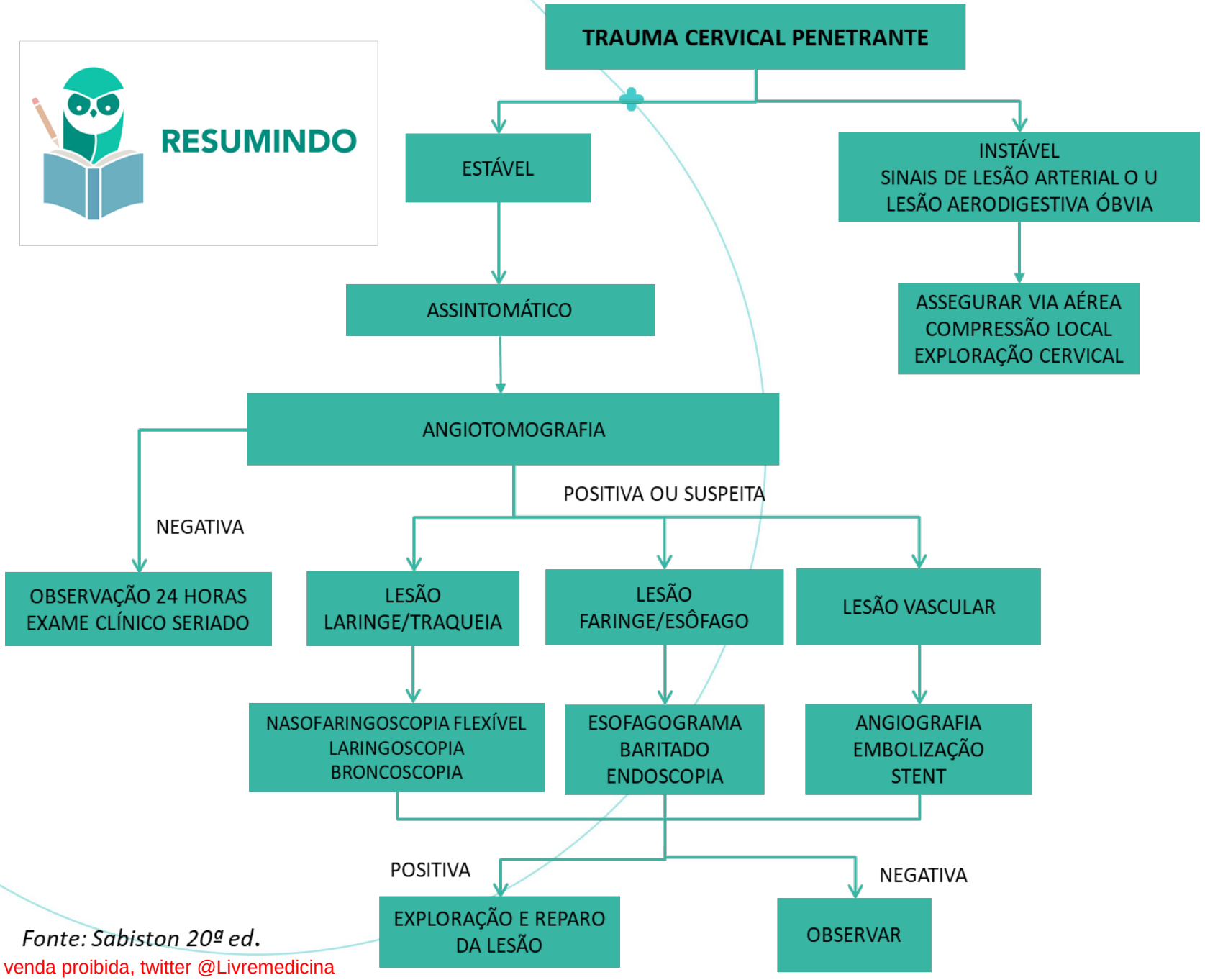
EXAMES COMPLEMENTARES NO TRAUMA CERVICAL

- ✓ Lesão vascular: Angiotomografia / Arteriografia /USG Doppler
- ✓ Lesão de laringe: Laringoscopia
- ✓ Lesão de traqueia: Broncoscopia
- ✓ Lesão de esôfago: EDA + esofagograma



Renatha Paiva
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RESUMINDO



Fonte: Sabiston 20ª ed.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

Homem, 30 anos, foi vítima de ferimento por projétil de arma de fogo no pescoço. Admissão no Centro de Trauma:

A: Conversando. Hálito etílico. SpO_2: 96% com máscara de oxigênio.

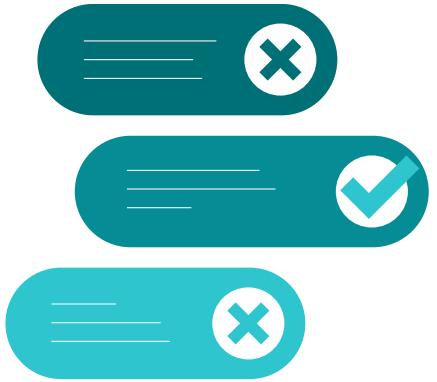
B: MV presente bilateralmente. Ausência de enfisema de subcutâneo torácico.

C: PA: 140x70 mmHg; FC: 105 bpm; tempo de enchimento capilar de 1 segundo.

D: Escala de coma de Glasgow de 15 (agitado).

E: Ferimento demonstrando na figura a seguir. Ausência de enfisema de subcutâneo.

Realizada analgesia com melhora da dor e agitação.



Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Cai na Prova

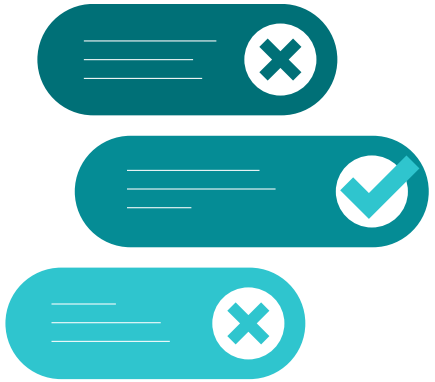
Assinale qual é a melhor conduta neste momento do atendimento.

a) Exploração local e sutura.

b) Cervicotomia exploradora.

c) Endoscopia e broncoscopia.

d) Tomografia com contraste.



Nome do professor

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

OBRIGADA



prof.renathapaiva

estrategiamed

med.estrategia.com

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina